

УДК: УДК:616.146-006.6-076.4:615.277.3-5

У.А.Аликулова

Жамбылский областной онкодиспансер

Клинико-цитологические особенности местнораспространенного рака шейки матки при применении неоадьювантной полихимиотерапии

Аннотация. Клинически и цитологически показана эффективность неоадьювантной полихимиотерапии при местнораспространенных формах рака шейки матки. При-менение неоадьювантной полихимиотерапии позволило перевести первично неоперабельные формы рака шейки матки в операбельные в 25(24,5%) случаях при II стадии и цитологический патоморфоз в 3 случаях с плоскокле-точного ороговевающего рака на Ca in situ.

Ключевые слова: рак шейки матки, неоадьювантная полихимиотерапия.

Рак шейки матки (РШМ), являясь визуально доступной локализацией, продолжает входить в число наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований, занимая пятое место в структуре онкологической заболеваемости в мире. Несмотря на возможности ранней диагностики данного заболевания, остается высоким процент заболеваемости по Республике Казахстан (РК) - 8,5‰, по Жамбылской области - 7,1‰. Смертность от РШМ по РК и Жамбылской области за 2009 год составила 4,4‰, запущенных форм РШМ (III-IV ст) по Жамбылской области за 2009 год - 9,6%. Поэтому лечение местнораспространенных форм РШМ остается актуальной проблемой онкогинекологии.

В настоящее время при распространенных формах (T2b, T3, T4) применяется, по возможности, радикальное хирургическое лечение с предоперационной лучевой терапией или химиотерапией. Данные современной литературы свидетельствуют о несомненной целесообразности применения неоадьювантной химиотерапии с включением платиносодержащих препаратов при планировании тактики лечения больных местнораспространенными формами РШМ.

Цель исследования

- изучение комплексных методов лечения больных с местно распространенными формами раком шейки матки в Жамбылском областном онкологическом диспансере.

Материалы исследования

В исследование включены больные раком шейки матки с впервые выявленным диагнозом за 2006-2009гг.

В Жамбылском ООД проводится три основных метода лечения: хирургический, комбинированный и сочетанная лучевая терапия.

Всего за исследуемые годы выявлены 135 больных РШМ. По стадиям больные распределены следующим образом: T1N0 (in situ)-1-0,7%, I-стадия- 19 (14,0%), II ста-

дия -102(75,5%) больных, из них T2aN0M0 - 47(47,0%), T2bN1M0 - 55(53,0%), III стадия - 11(8,1%) больных, IV стадия - 3(2,2%) больных. Возраст больных варьировал от 30 до 82 лет. Удельный вес больных по возрастам: 30-39 лет - 24(17,7%) пациентки, 40-59 лет - 77(57,0%), 60-69 лет - 17(12,5%) и 70 и <-14(10,3%). У всех больных диагноз верифицирован гистологически: плоскоклеточный рак выявлен у 113(83,7%), аденокарцинома – у 6 (4,4%), железисто-плоскоклеточный рак – у 13 (9,6%), ca in situ – у 3 (2,2%) больных.

Всем больным II стадией первым этапом комплексного лечения проведена неоадьювантная полихимиотерапия по схеме: цисплатин 80-100мг/м², адриабластин 60 мг/м², 5-фторурацил 1200 мг/м², в зависимости от степени распространенности процесса и чувствительности опухоли к химиотерапии от 1 до 4 курсов с трехнедельным перерывом.

Из 102 больных проведение неоадьювантной полихимиотерапии позволило перевести неоперабельные формы рака шейки матки в операбельные у 25 (24,5%). У 64 (62,7%) больных после неоадьювантной полихимиотерапии проведена сочетанная лучевая терапия из-за частичной регрессии параметриальных инфильтратов до суммарно очаговой дозы на т. А 72 Гр, на т. В - 54 Гр. У 11 (10,7%) больных отмечалось прогрессирование заболевания на фоне лечения. Установлен цитологический патоморфоз у 3 больных с плоскоклеточного ороговевающего рака на ca in situ.

Таким образом, клинически и цитологически показана эффективность неоадьювантной полихимиотерапии при местнораспространенных формах рака шейки матки. Применение неоадьювантной полихимиотерапии позволило перевести первично неоперабельные формы рака шейки матки в операбельные в 25(24,5%) случаях при II стадии и цитологический патоморфоз в 3 случаях с плоскоклеточного ороговевающего рака на ca in situ.

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. Широкое применения неоадьювантной полихимиотерапии позволило перевести первично неоперабельные формы рака шейки матки в операбельные в 25(24,5%) случаях при II стадии и цитологический патоморфоз в 3 случаях с плоскоклеточного ороговевающего рака на ca in situ. Таким образом увеличилось количество операбельных больных со II- III стадией заболевания.

Список литературы

- 1 Бохман Я.В.. Руководство по онкогинекологии. - М., 2002.
- 2 Козаченко В.П.. Рак шейки матки //Современная онкология. - 2000.
- 3 Статистические материалы 2 отделения Жамбылского ООД.

Тұжырым

У.А. Аликулова

Жамбыл облысының онкодиспансері

Неoadъювантты полихимиотерапияны қолданғаннан кейінгі клиника-цитологияда жергілікті жайылған жатыр мойнының обыры.

Жергілікті тораған жатыр мойны қатерлі ісіктің клиникасы мен цитологиясына неoadъювантты полихимиотерапиясының эсері көрсетті.

Неoadъювантты полихимиотерапиясын қолдану жатыр мойын қатерлі ісігінің алғашқы неоперабельді формасына операция жасауға болатын 25 (24,5%) жағдайда мүмкіндік тудырды. II сатыдағы жағдай цитологиялық патоморфоз 3 жағдай жалпақ жасушалы мүйізделген қатерлі ісік Ca in situ.

Түйінді сөздер: Жатыр мойнының обыры, неoadъю-

вантты полихимиотерапия/

Summary

U.A. Alikulova.

Zhambyl regional onkodispenser

Clinico-cytological features of locally advanced cervical cancer when used neoadjuvant polychemotherapy

Clinically and cytology demonstrated the efficacy of neoadjuvant chemotherapy in locally advanced cervical cancer. The use of neoadjuvant chemotherapy allowed to transfer primary inoperable form of cancer of the cervix in operable in 25 (24.5%) cases with stage II and cytological pathomorphosis in 3 cases with squamous keratinizing cancer Ca in situ.

Keywords: Cervical cancer, neoadjuvant chemotherapy/